Gli psicologi, i sociologi, gli assistenti sociali, gli educatori, i coordinatori e i responsabili dei servizi, gli assistenti domiciliari, ma anche i medici e il personale paramedico che lavorano nei servizi territoriali delle Asl, nei comuni, nel privato sociale (cooperative, volontariato, associazioni ricreative, culturali, ecc.) ma anche nelle aziende, nella scuola o come liberi professionisti, sempre più spesso sono chiamati a lavorare per, o su progetti.

La **costruzione**, la **stesura**, il **coordinamento di progetti**, la **valutazione di progetti** elaborati da altri, il **monitoraggio** e la **valutazione dei risultati** sono competenze già importanti, ma che lo diverranno ancor di più nei prossimi anni. Esse sono indispensabili, tra l'altro, per accedere a molte fonti di finanziamento (vedi ad es. fondi Commissione Europea, fondi legge Turco 285/1997). A fronte di queste necessità, la formazione di base degli operatori sociali è stata finora carente e gli operatori hanno cercato di porvi rimedio attraverso l'esperienza e l'approfondimento personale.

Il volume si rivolge sia agli studenti sia agli operatori che già stanno lavorando su progetti; per questi ultimi può costituire un'occasione per approfondire o sistematizzare le conoscenze e riflettere sulle proprie esperienze.

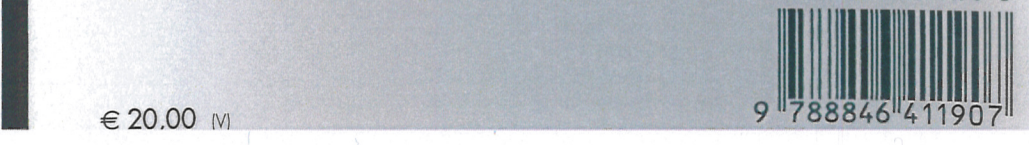
Pur privilegiando la dimensione metodologica, lungo tutti i capitoli l'attenzione viene focalizzata anche sulle altre dimensioni del processo di progettazione e valutazione: su quella valoriale, cognitiva ed emotiva, su quella organizzativa ed interorganizzativa e sugli aspetti relazionali e negoziali.

Il volume nasce dalla collaborazione dei due autori, che unendo un approccio più teorico, tipico degli universitari ed uno più pragmatico legato all'operare come consulente nel sociale, hanno cercato una sintesi ed un'integrazione.

Liliana Leone, si occupa di valutazione e consulenza organizzativa per organismi della Pubblica Amministrazione e del no-profit. Anche in collaborazione con altri professionisti, realizza valutazioni di policy, programmi, progetti, piani e servizi nell'ambito delle politiche sociali e sanitarie e delle politiche del lavoro. L'Autrice è responsabile di Studio CEVAS (Roma - www.cevas.it), Vice Presidente e Segretario Nazionale AIV Associazione Italiana di Valutazione.

Miretta Prezza, docente di Psicologia di comunità presso la Facoltà di psicologia dell'Università "La Sapienza" di Roma, si interessa da diversi anni ai temi della valutazione e progettazione degli interventi di prevenzione e promozione della salute.

ISBN 88-464-1190-0



€ 20,00 (V)

OSP
1056.5

L. LEONE, M. PREZZA COSTRUIRE E VALUTARE I PROGETTI NEL SOCIALE

L'OPERATORE SOCIALE NELLA PROFESSIONE

Liliana Leone
Miretta Prezza

COSTRUIRE E VALUTARE I PROGETTI NEL SOCIALE

Manuale operativo per chi lavora su progetti in campo sanitario, sociale, educativo e culturale



FrancoAngeli

Liliana Leone
Miretta Prezza

COSTRUIRE E VALUTARE I PROGETTI NEL SOCIALE

Manuale operativo per chi lavora su progetti in campo sanitario, sociale, educativo e culturale

FrancoAngeli

7a edizione Copyright © 1999, 2003 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

Ristampa
1 2 3 4 5 6 7

Anno
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

È vietata la riproduzione, anche parziale, effettuata a qualsiasi titolo, eccetto quella ad uso personale
Quest'ultima è consentita nel limite massimo del 15% delle pagine dell'opera,
anche se effettuata in più volte, e alla condizione che vengano pagati i compensi
stabiliti dall'art. 2 della legge vigente.
Ogni fotocopia che eviti l'acquisto di un libro è illecita ed è severamente punita.
Chiunque fotocopia un libro,
chi mette a disposizione i mezzi per farlo, chi comunque favorisce questa pratica
commette un reato e opera ai danni della cultura.

Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano.

2. Approcci e modelli della progettazione

2.1. Tappe di un progetto di intervento

A prescindere dal tipo di progetto realizzato (di prevenzione, formazione, sviluppo di comunità, ecc.), dal contesto (comunità o gruppo classe), dalla durata, dai destinatari o da altri elementi, possiamo rappresentare il percorso di un qualsiasi progetto di intervento attraverso cinque tappe. Il termine "progetto" può generare ambiguità perché è frequentemente utilizzato con un doppio significato: progetto come percorso complessivo di realizzazione di un intervento e progetto come prodotto cartaceo e stesura concreta di un disegno di intervento. Nella prima accezione si usa dire: "Abbiamo quasi terminato il progetto X e a dicembre iniziamo la fase 1 di ricerca-azione del progetto Y". Nella seconda accezione si usa, invece, dire: "Abbiamo presentato un progetto alla Regione..." o anche " Vuoi leggere il nostro progetto?".

Per evitare fraintendimenti utilizzeremo il termine "progetto" riferendoci al processo complessivo di ideazione, realizzazione e gestione, a meno che non stiamo riferendoci alla "stesura del progetto": in tal caso il termine rimanderà al prodotto "cartaceo" i cui requisiti, per una corretta formulazione, verranno analizzati nel quarto capitolo.

Nella figura 1 vi proponiamo uno schema estremamente semplificato che utilizzeremo in seguito per approfondire il discorso sui diversi approcci di progettazione.

Fig.1. Le tappe di un progetto

1° TAPPA IDEAZIONE	*2° TAPPA ATTIVAZIONE*	*3° TAPPA PROGETTAZIONE*	4° TAPPA REALIZZAZIONE	*5°TAPPA VERIFICA*

- **La prima tappa** corrisponde all'ideazione, al momento in cui una o più persone ipotizzano di realizzare un progetto, di attivare un'iniziativa, di fare o proporre qualcosa.
- **La seconda tappa** corrisponde a quella dell'attivazione.
  Una volta avviata una propria ipotesi di progetto bisogna cercare di verificare quali sono le risorse (umane, finanziarie e strumentali...) disponibili, identificare meglio il proprio ruolo e quello degli altri soggetti coinvolti in queste prime fasi, identificare il problema e le strategie d'intervento, ottenere il consenso più o meno allargato e analizzare la domanda della committenza.
- Segue **la terza tappa** dell'elaborazione di un progetto cartaceo, dell'identificazione e programmazione delle diverse fasi dell'intervento.
  Si cerca di prevedere quali saranno le esigenze di personale, i tempi, le necessità tecniche e materiali per garantire l'operatività.
- **La quarta tappa** corrisponde alla realizzazione dell'intervento. Attraverso l'avvio delle prime attività si verificano le proprie ipotesi, si attuano gli interventi ed i cambiamenti necessari per sostenere il progetto, si sviluppano processi di confronto e verifica *in itinere* per produrre gli aggiustamenti necessari.
- L'ultima, **la quinta tappa**, è quella della verifica conclusiva e della riformulazione, ridefinizione o conclusione del progetto stesso.

Esiste una logica sequenzialità tra le diverse tappe che tuttavia, si accavallano e talvolta sovrappongono.

La verifica è posta come ultima tappa anche se processi di monitoraggio e valutazione più o meno formalizzati ed espliciti si attivano lungo il percorso ad ogni tappa, così pure il processo di attivazione può proseguire parallelamente alla realizzazione dell'intervento.

Esistono più modi di intendere la progettazione e a seconda del modello di riferimento utilizzato, esplicitamente o più spesso implici-

tamente, troveremo che queste cinque tappe di un intervento vengono intese e si concretizzano in modo diverso.

Da come si configurano le prime tappe dell'intervento capiremo quale approccio viene utilizzato e agito. Intendiamo il progetto come prodotto conclusivo o come strumento all'interno di un percorso più ampio?

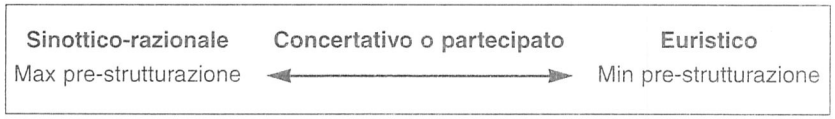
È in questo momento che si delimitano degli spazi di apertura e flessibilità del futuro progetto, che si sceglie quanto predefinire in anticipo, quanto tollerare modificazioni di rotta e incertezze.

2.2. Approcci della progettazione

Possiamo riassumere in tre tipologie gli approcci e gli orientamenti esistenti in merito alla progettazione di interventi nel sociale.

Chiameremo questi tre approcci "sinottico-razionale", "concertativo o partecipato" ed "euristico" (fig.2) e li porremo lungo un continuum dalla massima pre-strutturazione alla massima apertura.

Fig. 2. Tre approcci alla progettazione



In ciascun approccio, le cinque tappe logiche di un intervento sono sempre presenti ma, come vedremo in seguito, assumono pesi e rilevanze diverse.

Approccio sinottico-razionale

L'approccio "sinottico-razionale" è direttamente mutuato dalla programmazione sinottico-razionale di cui parleremo nell'ultimo capitolo (v. cap.7). Si tratta di un approccio "meccanicista" che rimanda ad una causalità di tipo lineare, i cui assunti sottostanti sono:

- è possibile circoscrivere i fattori causali alla base di disturbi e devianze individuali e sociali;
- è possibile realizzare progetti che modifichino tali fattori e così prevenire effetti indesiderati;
- è possibile modificare i comportamenti e gli atteggiamenti delle persone in funzione di disegni predeterminati.

In altri termini, s'ipotizza che sia possibile individuare nessi di causalità lineare relativamente alle problematiche sociali e, in base a questi, programmare e prevedere il cambiamento sociale.

Di solito l'utilizzo di tale modello si accompagna anche ad un'enfasi su aspetti connessi all'utilizzo di programmi molto strutturati e "strumenti" predefiniti.

L'approccio razionale è stato sviluppato nell'ambito del classico modello della scelta razionale elaborato principalmente dalle scienze economiche.

Per tale approccio il problema della progettazione può essere così formulato:

"in condizioni ambientali date trovare i mezzi migliori per raggiungere obiettivi dati giudicati desiderabili secondo criteri di valutazione stabiliti.

Queste formulazioni – scrive Lanzara – contengono tutta una serie di presupposti:

a) innanzi tutto l'ambiente è predeterminato, ed è descritto da vincoli e parametri che restano fissi nel corso della procedura;
b) si dà per scontato che il problema sia chiaro e non ambiguo, che gli obiettivi siano esplicitamente dati fin dall'inizio, e in più siano trasparenti e non soggetti a interpretazioni; essi non possono essere modificati o ridiscussi nel corso della progettazione;
c) i mezzi alternativi – le opzioni di scelta – per conseguire i fini e i criteri di valutazione della prestazione sono dati in modo distinto dai fini;
d) infine, perché si possa effettivamente trovare una soluzione coincidente con il valore massimo dell'utilità (o col minimo costo), si presuppone che sia data una struttura ordinata di preferenze relative alle conseguenze della scelta, che non viene modificata nel corso del processo di scelta stesso." (Lanzara, 1985, p. 340).

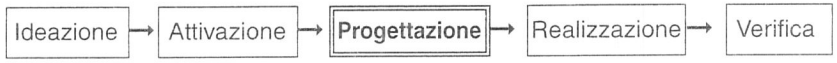
Una tale impostazione comporta una forte stilizzazione e sem-

plificazione delle situazioni che invece "il progettista si trova ad affrontare: situazioni in cui i problemi non sono chiaramente definiti, l'ambiente è incerto e confuso, gli obiettivi sono espressi in modo vago e approssimativo, o sono variabili, o conflittuali, o non chiaramente distinguibili dai mezzi", dal come si fanno le cose (Lanzara, 1985, p. 341).

Un'altra caratteristica del modello del *problem-solving*, che rientra nell'approccio razionale, è quello di riferirsi ad un progettista solitario e di dare una rappresentazione individualista del processo di progettazione.

All'interno delle cinque tappe di un intervento (fig.3) questo modello considera come cruciale ai fini della riuscita dell'intervento la tappa della progettazione: a questa vengono riconosciute attenzioni e date cospicue risorse; le altre tappe connesse alla realizzazione del progetto si presume debbano seguire di riflesso.

Fig.3. Le tappe del progetto nell'approccio "sinottico-razionale"



In tale approccio, infatti, la centratura è sul prodotto da realizzare, inteso come risultato previsto a priori.

È scarsa la presenza della tappa "attivazione"; quando è presente si riferisce alla ricerca di finanziamenti e all'attivazione di reti di relazioni e risorse materiali necessarie all'approvazione del progetto e a creare una sufficiente alleanza con il committente.

Non vi sono processi di reale partecipazione dei destinatari o dei diversi soggetti coinvolti nel progetto.

Per elaborare il "progetto" inteso come prodotto cartaceo in cui sono indicati gli obiettivi e disegnati tutti i passaggi del futuro intervento, si attivano comitati di esperti a livello nazionale, si tengono numerose riunioni e s'impegnano ingenti risorse in termini economici e di tempo.

La tappa della realizzazione viene posta in secondo piano, dovrebbe essere una conseguenza del progetto: l'implementazione, così sono chiamate quell'insieme di attività che accompagnano e sostengono la

realizzazione del progetto, va monitorata, seguita ma non si sospetta che, di fatto, è lì, nell'incontro con i destinatari, nella fase di contatto, che si svilupperanno i "giochi" più significativi ai fini dell'efficacia di un progetto.

Le alleanze, le sponsorizzazioni ed i processi di negoziazione e di gestione dei conflitti realizzati a livelli "alti" assorbono tutte le energie.

Nei servizi sappiamo che "l'ultimo anello della catena" determina la qualità del servizio stesso, eppure, ad es., nella formazione spesso vengono determinati in modo dettagliatissimo obiettivi specifici, tempi di ciascun contenuto, temporalizzazioni, funzioni e macro funzioni che dei soggetti astratti dovranno andare a svolgere, pesi assegnati a ciascuna materia-area di contenuto e si tralasciano altri elementi critici.

Con che criteri verranno selezionate le persone, che attese svilupperanno? Chi farà formazione, che condivisione del progetto vi è?

In un approccio di tipo "sinottico" il progetto viene costruito a partire da una comprensione "a priori" dei bisogni, o comunque estranea e lontana dai soggetti "portatori del problema", e il processo di progettazione non viene allargato a diversi soggetti ma rimane una competenza specifica dell'esperto (operatore, consulente, educatore, ecc.).

La valutazione si riferisce essenzialmente ad un processo di confronto tra "*output* previsti ed *output* ottenuti", in una logica di ricerca dello "scarto" della "mancanza".

Questo modo di intendere la valutazione è consono al modello che, come detto, riguarda attività sufficientemente standardizzate da prevederne gli esiti.

Difficilmente si andranno ad evidenziare i processi di apprendimento spontaneo realizzatisi tra gli attori in gioco o gli impatti imprevisti.

Anche relativamente al concetto di efficacia e risultato ottenuto, più frequentemente si verificherà il livello di produttività. Si evidenzieranno indicatori connessi non tanto ai risultati intesi come vantaggi e aumento della qualità della vita dei destinatari, quanto indicatori connessi alle attività prodotte (n. di persone che hanno frequentato, n. e tipologia di utenza in carico, n. nuovi casi, n. di colloqui, n. di riunioni...) lasciando implicitamente intendere che il "fare" certe attività implichi che le stesse attività siano davvero utili per i destinatari finali (gli utenti-clienti).

Un esempio di progetto educativo di tipo "sinottico-razionale" può essere dato anche da un certo tipo di programmazione didattica.

Gli insegnanti tra loro riuniti, all'inizio dell'anno scolastico, tracciano il programma didattico: si tratta di inviduare obiettivi didattici e educativi generali, di scomporli in obiettivi specifici (od operativi) ed infine, di individuare i criteri di verifica. Gli obiettivi vengono individuati "a priori", in un certo senso a prescindere dalle specifiche caratteristiche sia dei futuri alunni (e genitori), sia delle dinamiche di classe che si svilupperanno. Si prevede un percorso rettilineo: non si lasciano porte aperte alle incertezze, alle varianze connesse alla soggettività, ad eventuali diramazioni nel cammino ed a sperimentazioni flessibili, non si accolgono e valorizzano risorse impreviste o possibilità emergenti.

Tanto più il contesto in cui si realizza l'intervento ha caratteristiche di complessità, di incertezza e imprevedibilità, tanto più quest'approccio risulta inadeguato o fuorviante perché non riesce ad accettare le variazioni provenienti dall'ambiente, a modellarsi con velocità ai cambiamenti che insorgono.

Detto questo bisogna ammettere che, sebbene sia il meno adatto ad orientare interventi di tipo sociale (in particolare quelli che prevedono una realizzazione all'esterno delle istituzioni, a livello di comunità), tale approccio "piace" e in un certo senso ha successo!

Piace perché è attraente e rassicurante anche per i clienti, i destinatari: è molto tranquillizzante sentirsi dire "se seguirete questo programma di 5 giornate vi aiuteremo a risolvere il problema che vi affligge, ne hanno già beneficiato altre centinaia di persone".

Ha successo dal punto di vista commerciale: è ben codificato. È il modello "forte" per definizione, è consolidato nella nostra cultura, rimanda all'idea di razionale e di ordine, di cambiamento programmato e controllabile: è così consolidato che spesso l'idea di progettazione si associa automaticamente a tale approccio.

Le distorsioni dell'approccio sinottico-razionale

Gli assunti su cui si basa l'approccio sinottico-razionale sono alla base di una serie di distorsioni frequentemente rilevabili nei processi

di progettazione. Analizziamoli in ordine a partire da quelle relative al *ruolo del decisore* ed *alla definizione dell'obiettivo.*

Il modello razionale assume che vi sia un ipotetico decisore in grado di individuare il problema, definire gli obiettivi, vagliare le ipotetiche alternative, scegliere la soluzione più adatta.

Un problema cruciale nell'area dei servizi (e gran parte delle politiche pubbliche si concretizzano in servizi) è quello della motivazione del personale e della condivisione degli obiettivi.

In una società di servizi colui che eroga direttamente il servizio ha un notevole potere nel rapporto diretto con l'utente ed ha un margine di interpretazione dell'obiettivo tale da modificarlo o talvolta stravolgerlo.

Ipotizziamo che una cooperativa sociale gestisca, in convenzione con un comune, un servizio di assistenza domiciliare per anziani; immaginiamo che il progetto di intervento per ogni singolo anziano è individuato dall'assistente sociale del comune e che questo sia poi discusso con l'assistente sociale della cooperativa. Si avvia l'assistenza domiciliare ad un'anziana e due assistenti domiciliari si recano a giorni alterni per due ore dalla signora.

Chi decide l'obiettivo dell'intervento?

Prevarrà l'obiettivo dell'assistente sociale del comune, quello dell'assistente sociale della cooperativa, quello del primo o del secondo operatore assistente domiciliare, quello dell'anziana signora o quello dei figli della signora?

In realtà l'obiettivo dell'intervento risente di ancora altri livelli, è influenzato dalle leggi nazionali e regionali in materia e dalla convenzione che regola il servizio e che definisce gli obiettivi del servizio nel suo complesso.

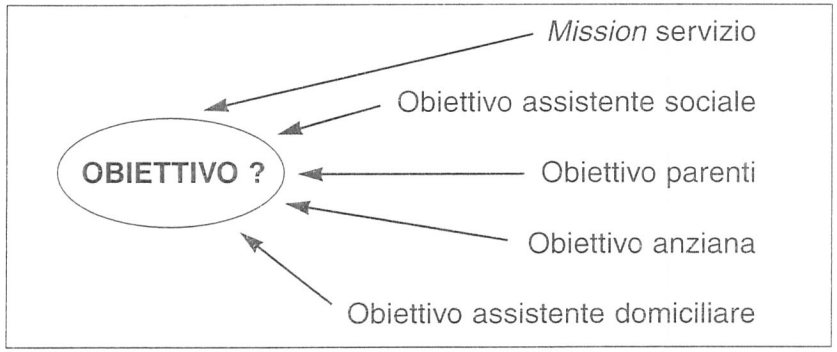
Non esiste un unico decisore in grado di orientare e controllare un intervento senza processi di negoziazione, co-decisione, corresponsabilità con altri soggetti.

L'assistente domiciliare ha tuttavia un ruolo privilegiato nell'orientare l'intervento: se è convinto che quella persona non ha alcuna possibilità di mantenersi autonomamente a domicilio, si porrà in modo da non favorire il ripristino o il mantenimento delle capacità funzionali. Ci sono diversi modi di porgere aiuto; anche attraverso le semplici cure domestiche si possono inviare messaggi che rafforzano l'autonomia

delle persone o che rinforzano, viceversa, i processi di dipendenza e lo stabilizzarsi di bassi livelli di autosufficienza.

Questo semplice esempio mette in evidenza come in realtà quando parliamo di "obiettivi" non possiamo immaginare un processo di semplice elencazione e fissazione di ciò che si prevede di raggiungere in tempi definiti. L'individuazione di un obiettivo si realizza grazie a processi di negoziazione tra i diversi attori coinvolti (v. fig. 4).

Fig.4. Individuazione di un obiettivo



Esiste, inoltre, sempre uno spazio di interpretazione ed una distanza tra obiettivo dichiarato e obiettivo perseguito.

La distanza tra decisore ed esecutore rappresenta quindi un punto critico: man mano che si frappongono attori diversi, livelli organizzativi, enti, ruoli e gerarchie tra momento decisionale e momento esecutivo, tanto più è probabile che si riduca la possibilità di orientare e prevedere cosa sarà realizzato.

Il nesso tra programmazione a livello centrale e la realizzazione di singoli progetti può diventare quasi nullo: gli obiettivi di partenza possono essere stravolti e il progetto può essere utilizzato unicamente a scopo strumentale per accedere alle risorse, per aumentare la propria influenza o per altre ragioni. Così pure il nesso tra progetto e singolo intervento può affievolirsi se non vi è una forte condivisione dell'obiettivo ed una vicinanza tra ruolo decisionale e ruolo operativo, tra chi definisce un progetto e chi lo realizza.

"Nella maggior parte delle situazioni della vita – e soprattutto

nelle organizzazioni – la progettazione è un processo d'indagine e di strutturazione collettiva che avviene mediante transazioni e conversazioni tra più attori in interazione. (...)". Può darsi che progettisti diversi non solo diano soluzioni diverse allo stesso problema ma che "non si trovino d'accordo su quale sia il problema. Si deve di conseguenza ammettere che una dimensione fondamentale e costitutiva dei processi di progettazione sia costituita dal conflitto, dalla disputa, e dalla divergenza tra strategie e soluzioni diverse " (Lanzara, 1985, p. 347).

Una fonte d'incertezza è dunque rappresentata proprio dai diversi attori-progettisti che non hanno necessariamente interessi, obiettivi e potere d'influenza coincidenti, il cosiddetto *task environment*, o ambiente relativo al compito, non è un dato a sé stante ma è influenzato e prodotto dalle relazioni sociali degli stessi progettisti.

Un artefatto progettuale, il prodotto cioè del processo di progettazione (ad es.il progetto di assistenza domiciliare sul singolo caso), è sempre la risultante di una serie d'interazioni tra i diversi attori impegnati in tale processo. Com'è definito un problema, ed anzi quale problema diventa oggetto d'indagine e quale no, ha a che fare con i tipi di rappresentazioni e i tipi d'interazioni realizzate tra i diversi soggetti.

Un altro punto critico presente nell'approccio sinottico-razionale è l'assunto che sia possibile sempre effettuare una comparazione tra le diverse opzioni o strategie e scegliere in base ad un'ipotesi di massimizzazione dei benefici.

Nei casi in cui il settore d'intervento è ancora "immaturo", come poteva essere una quindicina di anni fa l'intervento per le tossicodipendenze e come può essere oggi il problema della creazione di nuove forme di lavoro, il decisore in realtà non possiede ancora adeguate conoscenze per individuare le metodologie d'intervento più efficaci.

In questi casi è fuorviante identificare tutte le tappe della progettazione lasciando pochi spazi di sperimentazione, di verifica e cambiamento lungo il percorso.

L'approccio sinottico-razionale non aiuta a pensare il progetto come uno strumento flessibile capace di adattarsi lungo il processo, di riorientare i processi decisionali, di definire a tappe successive altri elementi; ci si aspetta che il progettista-decisore debba in un certo senso predire il futuro e permanere nelle proprie scelte.

Approccio "concertativo o partecipato"

Dall'approccio "concertativo" derivano i modelli di progettazione partecipata.

Quest'approccio si muove da una critica dell'approccio "sinottico-razionale" in quanto tale modello ha tralasciato proprio la dimensione processuale, il livello dell'interazione sociale ed il livello cognitivo ed emotivo.

Considerare la dimensione dell'interazione sociale ci rimanda – secondo Pozzobon (Pozzobon, 1994) – alle questioni del "punto di vista" e a quella del "potere".

"La prima questione sottolinea la necessità di tener conto del fatto che durante il processo di progettazione interagiscono diverse prospettive da cui si definisce il problema e si struttura l'ambiente in modo non sempre coincidente (...). Ciò si traduce in una serie di interrogativi del tipo: chi definisce le risorse e i vincoli? Chi individua le strategie? Chi realizza concretamente quanto stabilito? A chi serve e chi deve effettuare la valutazione?

In stretta connessione con questi problemi si colloca la questione del potere. Il processo di progettazione appare, infatti, costellato di decisioni che ne orientano il corso successivo e che sono anch'esse frutto di processi di negoziazione condotti tra i diversi attori implicati in funzione della loro posizione nell'organizzazione" (Pozzobon, 1994, p. 14).

Le decisioni sono di diverso genere – strategiche, operative, ecc. – e i diversi attori hanno potere di influenza diverso sul tipo di decisione a seconda del proprio ruolo e posizione organizzativa.

L'approccio cui facciamo riferimento quando parliamo di "approccio concertativo-partecipato", e cui fanno riferimento Pozzobon ed altri autori, rappresenta un insieme piuttosto eterogeneo di impostazioni teoriche provenienti da diversi ambiti disciplinari che condividono l'assunto secondo il quale la conoscenza non si basa sulla corrispondenza con la realtà esterna, ma sempre solo sulle "costruzioni" di un osservatore.

Non trattandosi di un approccio fortemente codificato diversi autori utilizzano terminologie e definizioni non omogenee per identificare o sottolineare aspetti diversi di questo approccio alla progettazione. In un recente articolo riferito alla progettualità come produzione di inter-conoscenze o anche "progettualità dialogica" si afferma che: "...un modo per affrontare l'incertezza, l'ambiguità e la frammentazione che attraversano i contesti lavorativi è quello di attivare una progettualità intesa come processo di comunicazione volto a produrre conoscenze intersoggettive contestuali. Tali conoscenze devono offrire la possibilità di costruire dei significati almeno parziali delle azioni o delle decisioni intraprese" (Brunod, d'Angella, Orsenigo, 1998, p. 37).

Siamo abituati a pensare che la realtà può essere "scoperta". Il costruttivismo, al contrario, sostiene che ciò che definiamo realtà è un costrutto personale, un'interpretazione, un modo particolare di osservare, spiegare e rappresentarsi il mondo che è costruito attraverso l'esperienza e la comunicazione. Secondo tale approccio la realtà non sarebbe scoperta ma "inventata" (Watzlawick, 1988).

Sul piano del processo di progettazione le conseguenze sono che:

- il problema e l'ambiente non sono dati a priori come fatti oggettivi;
- il processo di interazione tra i diversi attori coinvolti nel processo di progettazione prosegue in tutte le sue tappe;
- pur condividendo un impianto logico comune, ogni attore continua ad essere portatore di aspettative, presupposti cognitivi, posizioni di potere diverse e ad avere ampi margini di autodeterminazione e negoziazione.

In questo secondo approccio si parte da un'ipotesi di cambiamento di una data realtà che è confrontata, negoziata, concertata con i destinatari; troviamo, infatti, che rispetto all'approccio precedente, viene data maggiore rilevanza alla tappa dell'attivazione (fig. 5). Le frecce nei due sensi tra una tappa e l'altra indicano che esiste un'influenza reciproca tra le diverse tappe.

Fig.5. Le tappe del progetto nell'approccio concertativo



Nello schema viene rappresentato, in modo più dettagliato, il percorso di un intervento realizzato secondo un approccio concertativo. Si tratta di una rielaborazione di modelli di progettazione utilizzati nell'ambito della progettazione di interventi di prevenzione delle tossicodipendenze (Regogliosi 1986, 1992).

Percorso di un progetto di intervento realizzato secondo un approccio concertativo

1° **tappa: Ideazione**
Iniziativa interna al servizio:
- *Decodifica delle motivazioni*
- *Analisi delle relazioni*
- *Analisi dei dati*

Se viene accolta una richiesta esterna:
- *Decodifica della domanda*
- *Analisi dei dati*

2° **tappa: Attivazione**
- Consolidamento e *allargamento della committenza*
  Prima lettura del contesto locale
- Definizione del "contratto" tra i diversi soggetti: *ruoli e funzioni*
- *Analisi del bisogno*
- *Analisi della comunità locale* (storia e cultura locale, profilo demografico ed economico ecc.) *e delle relazioni tra i soggetti interessati*
- Individuazione di *ipotesi comuni* di interpretazione del disagio
- Individuazione delle *finalità* di un intervento e dei destinatari

3° **tappa: Progettazione**
- Stesura di una *prima bozza di progetto*
- *Condivisione* tra diversi soggetti coinvolti della bozza di progetto
- Stesura *progetto definitivo*

4° **tappa: Realizzazione**
- Realizzazione *dell'intervento*

5° **tappa: Valutazione**
- *Verifiche* periodiche del progetto
- *Riprogettazione* eventuale di ulteriori interventi

Come si potrà notare, la stesura di una prima bozza del progetto rappresenta, in un approccio "concertativo", solo una tappa del percorso complessivo e non il momento iniziale.

Nel prossimo capitolo analizzeremo più in dettaglio le prime tappe della progettazione esposte in questa tabella, tuttavia, per quanto riguarda ora il nostro discorso, si osservi come una serie di elementi costitutivi di un progetto diventino oggetto di analisi e condivisione di più soggetti promotori del progetto.

Alla base di questo approccio c'è la convinzione che:
- i "problemi" sociali non sono caratterizzati da una causalità lineare;
- esistono sempre più letture dei bisogni e più ipotesi interpretative;
- il ruolo dei servizi e degli operatori non è quello di distribuire ricette e soluzioni ma di aiutare ad "aiutarsi", quello di promuovere *empowerment* a livello di individui e di comunità;
- le persone hanno grandi potenzialità e sono in grado di auto organizzarsi, di attivare risorse e di impegnarsi in azioni e progetti delle/dei quali sentano l'utilità ed il significato.

Questo approccio rifiuta una lettura dei bisogni dell'utenza "a priori", un'interpretazione tecnica non condivisa da parte dei destinatari. L'interazione tra i diversi attori impegnati in un progetto caratterizza tutte le tappe, da quella di attivazione in cui si costruiscono ipotesi condivise di spiegazione e interpretazione dei fenomeni a quella vera e propria della progettazione, in cui si individuano insieme alcuni obiettivi dell'intervento, a quella della valutazione, in cui si verificano, secondo i punti di vista dei diversi soggetti, i risultati.

Scambiare e confrontare le reciproche percezioni del "problema", confrontare i dati in possesso sulla cui base gli operatori esprimono dei giudizi e definire con chiarezza i ruoli e le funzioni di diversi soggetti coinvolti in un progetto, sono alcuni passaggi indispensabili che si collocano a monte di un progetto.

Fa parte di questo approccio il modello di progettazione a cerchi concentrici elaborato dall'animazione socio-culturale (Regogliosi, 1986; 1997).

Il modo e il momento in cui coinvolgere esplicitamente – in molti casi lo sono, di fatto, a prescindere dalla volontà del progettista – altri attori nel processo di progettazione non sono indifferenti in questo approccio.

Ciascuno dei soggetti facenti parte della rete dei servizi potrebbe essere coinvolto nel progetto sin dalle tappe iniziali o solo in seguito, a progetto avviato.

Il momento e le modalità con cui coinvolgere altri soggetti sono cruciali ai fini della riuscita di un progetto; talvolta prevale una prati-

ca di lavoro per compartimenti stagni che spinge gli operatori a considerare come risorsa solamente il proprio lavoro "diretto". Le persone vengono chiamate a collaborare sulla base di progetti predefiniti, "chiusi", senza spazi di contrattazione, sulla base di scelte già fatte.

Avere un ruolo attivo all'interno di un progetto significa necessariamente, almeno in parte, *co-progettare*, essere partecipi anche nella elaborazione di alcune scelte strategiche od operative, senza confondere l'acconsentire con un partecipe coinvolgimento, la collaborazione con l'adesione.

Co-progettare significa attivare confronti e negoziazioni, ma anche allungare i tempi di una decisione, superare situazioni di stallo, gestire conflitti e dinamiche di potere tra servizi e persone, rinunciare a disegni lineari e preordinati, stabilire ruoli, funzioni e modalità di coordinamento.

Approccio "euristico"

Nell'approccio "euristico" (da *eurisko*= ricerco) si rinuncia a conseguire degli obiettivi predeterminati a monte dagli operatori-progettisti.

Esiste un fine, un'individuazione di strategie, uno specifico contesto e poi esiste un processo condiviso di ricerca partecipata attraverso cui si definiranno, con i soggetti, "destinatari", obiettivi specifici, interventi e ipotesi trasformative più mirate.

Mentre l'approccio "concertativo" realizzava una progettazione flessibile in cui si definivano alcuni obiettivi e altri rimanevano "aperti", questo terzo approccio non individua proprio obiettivi specifici a priori.

L'assunto alla base di questo approccio è che la centratura sul "prodotto", sulla riuscita di un risultato predefinito può indurre a porre in secondo piano l'attenzione ai "processi", ai modi con cui si realizzano le cose, al come e cioè ai reali risultati di un intervento sociale.

Altra motivazione alla base di questo approccio è la constatazione che molti progetti pensati per "aiutare" hanno prodotto effetti indesiderati, dipendenza degli "assistiti" dai servizi, assistenzialismo e squalifiche dei destinatari stessi.

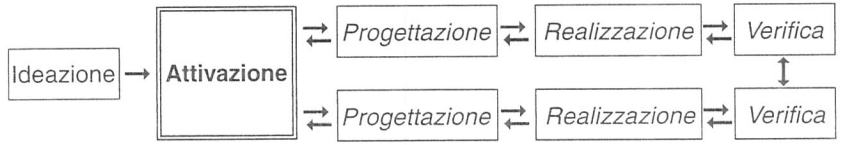
È a tutti noto il processo di "etichettamento" che si realizza nel momento in cui un servizio socio-educativo esplicitamente e pubblicamente si rivolge ad un gruppo di ragazzi "deboli": tale identificazione confermerà e svilupperà identità negative, svilupperà appartenenza a sottogruppi sociali emarginati ed emarginanti e rischierà di precludere l'instaurarsi di relazioni sociali tra pari e con altre figure adulte basate sulla reciprocità.

Molti progetti pensati per contesti marginali hanno continuato a riconfermare modelli emarginanti.

La spiegazione di tali effetti indesiderati secondo molti non va ricercata nell'inadeguatezza del progetto o nella sua scorretta realizzazione e applicazione ma nello stesso modello di progettazione; in altri termini nel modello di cambiamento sociale implicitamente assunto dai responsabili del progetto.

Questa è la ragione per cui, in alcuni progetti di intervento nel sociale, vengono scelte delle metodologie, come la ricerca-intervento partecipante, che privilegiano proprio processi di tipo partecipativo, di sviluppo della conoscenza, piuttosto che la raccolta di dati fruibili solo da pochi esperti.

Fig.6. Le tappe della progettazione nell'approccio euristico



L'approccio euristico (v. fig. 6) pone al centro del processo di intervento nel sociale la tappa dell'attivazione; la progettazione di uno specifico intervento è intesa come prodotto di percorso e non come luogo di partenza. A seguito della tappa denominata attivazione possiamo constatare che possono svilupparsi molteplici sotto-progetti. Come si può osservare dal grafico, possono svilupparsi diversi nuclei progettuali tra loro connessi, caratterizzati da un proprio percorso di progettazione, realizzazione e verifica.

Il primo progetto realizzato secondo un approccio euristico lo conobbi quando intervistai un'esperta di cooperazione internazionale

che per un'ONG (Organizzazione non governativa per la cooperazione internazionale) aveva lavorato oltre 10 anni in Burundi (v. scheda capitolo 2).

Le chiesi un'intervista sul tema della progettazione e poi le proposi di rappresentarmi graficamente il concetto di "progetto".

Si trattava di un espediente che mi aiutava ad esplicitare la "mappa cognitiva" esistente su quel concetto. Lei prese carta e penna, tracciò una lunga linea continua e dietro al foglio pose la parola: "progetto". Mi spiegò in seguito che era molto contrariata e che secondo lei molti progetti si erano rilevati poco utili.

Si riferiva ai progetti calati dall'alto, irrispettosi delle comunità e pensati secondo logiche meccaniciste. Secondo la sua esperienza di cooperazione internazionale, un percorso di attivazione di una comunità locale doveva nascere da un percorso comune di analisi dei bisogni e delle risorse a seguito del quale potevano prodursi dei microprogetti, basati sulle iniziative che autonomamente la gente *in loco* organizzava.

Negli ultimi anni in Italia sono stati realizzati diversi progetti che, a partire dall'analisi dei dati relativi ad un certo fenomeno (ad es.: minori in difficoltà), intendevano promuovere una presa in carico da parte della comunità locale dei problemi di alcuni soggetti (ad es.: soggetti in età evolutiva). Una di queste esperienze è rappresentata dal "Progetto nazionale per la sperimentazione coordinata di progetti adolescenti nel mezzogiorno" promosso dal Ministero dell'interno (Ministero dell'interno, 1994) e dalla Fondazione E. Zancan.

In tali esperienze l'elaborazione di specifici progetti di intervento rappresentava una delle ultime tappe del processo.

La prima tappa di questi progetti, che utilizzano una metodologia partecipante, di solito consiste in un'analisi condivisa del contesto, delle risorse e dei dati relativi al disagio adolescenziale. La tappa seguente riguarda l'individuazione di ulteriori soggetti ed istituzioni da coinvolgere affinché la comunità si faccia realmente carico dei bisogni dei soggetti in età adolescenziale e l'avvio di un processo di coinvolgimento a partire da riflessioni e confronti sulle diverse "letture" del disagio presenti nei servizi pubblici e del privato sociale.

Solo in seguito, di solito, si realizzano scelte operative, protocolli di intesa tra istituzioni e si avviano specifici progetti di intervento.

L'ipotesi sottostante a tale impostazione è che fare prevenzione significa "ridare dignità al contesto" e valorizzare le risorse informali e formali presenti nel territorio.

Anche se tracciate in brevi linee si può notare che il contenuto fondamentale di tali esperienze consiste nella rilevanza data alle fasi di analisi del problema, del contesto, della comunità ed alla presenza di ricerche basate sulla metodologia della ricerca-azione *(action-research)*.

Quando il successo di un intervento dipende dalla mobilitazione di iniziative della popolazione o dall'operare integrato di molteplici soggetti organizzativi, per loro natura poco connessi tra loro, allora il progetto inteso come strumento di una razionalità lineare, risulta inefficace ed anzi gravemente disturbante.